

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Abdominoperineal Resection of Rectum

الاستئصال البطني العجاني

A. Interpreter / Cultural Needs

An Interpreter Service is required? ☐ Yes ☐ No
If Yes, is an Interpreter present? ☐ Yes ☐ No

B. Condition and treatment

The doctor has explained that you have the following condition: (Doctor to document in patient's own words)

This condition requires the following procedure.
(Doctor to document - include site and/or side where relevant to the procedure)

The following will be performed:
An abdominoperineal resection of the rectum involves the removal of the lower part of the large bowel, the rectum (back passage) and the anal region through the abdomen and the perineum (the skin between the anus and the genitals).

The anal area is stitched together and will remain permanently closed.

The end of the large bowel is brought out through the wall of the abdomen as a colostomy. This is permanent and allows the bowel content to drain into a bag worn over the colostomy.

C. Risks of abdominoperineal resection of rectum

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following.

General risks:

- Infection can occur, requiring antibiotics and

أ. الترجمة\ الاحتياجات اللغوية والثقافية
هل توجد حاجة لمترجم؟ ☐ لا ☐ نعم
في حال وجودها، هل هناك مترجم حاضر؟ ☐ لا ☐ نعم

ب. الحالة الطبية والعلاج
قام الطبيب بشرح حالتك الصحية كالآتي: (يقوم الطبيب بتوثيق الحالة الصحية كما وصفها المريض)

تتطلب الحالة الصحية العملية أو الإجراء التالي
(يقوم الطبيب بالتوثيق - يتضمن الموقع و/أو الجانب المعنيين بالإجراء)

سيتم إجراء العملية التالية:
الاستئصال البطني العجاني هي عملية جراحية تتم لإزالة الجزء السفلي للأمعاء الغليظة والمستقيم ومنطقة الشرج المارّة خلال منطقة البطن والعجان. (منطقة الجلد ما بين فتحة الشرج والأعضاء التناسلية).

سيتم خياطة وإغلاق منطقة الشرج وستبقى مغلقة على شكل دائم.
ستثبت نهاية القطع في الأمعاء على فتحة في سطح البطن، ليتم جمع فضلات الجسم والتخلص منها في كيس.

ج. مخاطر الاستئصال البطني العجاني

هناك بعض المخاطر والمضاعفات المصاحبة لهذه العملية، وهي تشمل ولكن لا تقتصر على ما يلي:

مضاعفات ومخاطر عامة:
• الإصابة بالعدوى والالتهابات ما يتطلب استخدام المضادات

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

further treatment.

- Bleeding could occur and may require a return to the operating room. Bleeding is more common if you have been taking blood thinning drugs such as Warfarin, Aspirin, Clopidogrel (Plavix or Iscover) or Dipyridamole (Persantin or Asasantin).
- Small areas of the lung can collapse, increasing the risk of chest infection. This may need antibiotics and physiotherapy.
- Increased risk in obese people of wound infection, chest infection, heart and lung complications, and thrombosis.
- Heart attack or stroke could occur due to the strain on the heart.
- Blood clot in the leg (DVT) causing pain and swelling. In rare cases part of the clot may break off and go to the lungs.
- Death as a result of this procedure is possible.

Specific risks:

- Leakage where the bowel was stitched together. This may need further surgery.
- Deep bleeding in the abdomen. This may need fluid replacement or further surgery.
- Bowel is paralysed, causing abdominal bloating and vomiting. This is usually temporary.
- The wound may become infected. This is usually treated with antibiotics or the wound may need to be opened.
- Urinary tract infection. Antibiotics may be used to control the infection.
- Infection in the abdominal cavity. This may form an abscess may need drainage and antibiotics.
- The bowel may be unable to be joined and may be brought to the surface as a stoma, with the following problems:
- The blood supply to the stoma may fail and

الحويية وإجراءات علاج أخرى.

- قد يحدث نزيف ما قد يستلزم العودة لغرفة العمليات. ستكون أكثر عرضة للنزيف إذا كنت تتناول أدوية مضادة للتخثر مثل الوارفارين، الأسبرين، كلوبيدوجريل (بلافكس أو اسكوفر)، أو ديبيريديمول (أساسانتين أو بيرسانتين).

- قد تصاب أجزاء صغيرة من الرئة بالانخماص أو الانهيار ما يزيد خطر الإصابة بالعدوى والالتهاب، ما قد يتطلب استخدام المضادات الحيوية والعلاج الفيزيائي الطبيعي.
- في المرضى المصابين بالسمنة، تزيد نسبة الإصابة بالعدوى والالتهاب في الجرح أو الرئة، والإصابة بمضاعفات في القلب والرئة أو الإصابة بالجلطة.
- قد تصاب بذبحة صدرية أو جلطة نتيجة الضغط على القلب.

- حصول جلطة أو تخثر في الرجل (الإصابة بالخطر الوريدي العميق) ما يسبب ألم وتورم، وفي حالات نادرة قد تنفصل الجلطة وتصل للرئتين.
- قد تحدث الوفاة نتيجة للقيام بهذا الإجراء.

مضاعفات ومخاطر خاصة بالعملية:

- تسرب في موقع خياطة الأمعاء، وقد يتطلب ذلك تدخل جراحي إضافي.
- نزيف عميق في منطقة البطن، ما قد يتطلب استبدال سائل أو جراحة إضافية.
- شلل في الأمعاء مسبباً انتفاخاً وتقيؤاً، وعادة ما يكون هذا الأمر مؤقتاً.

- قد يصاب الجرح بالالتهاب. عادة ما يعالج هذا الأمر باستخدام المضادات الحيوية أو فتح الجرح.

- التهاب المجرى البولي ويعالج ذلك بالمضادات الحيوية.

- التهاب في تجويف البطن ما قد يتسبب في تكون الخراج، ويعالج ذلك بالتصريف والمضادات الحيوية.

- عدم القدرة على ضم الأمعاء وخياطتها ما قد يتطلب إخراجها على شكل فقرة على سطح الجسم، والمخاطر المتعلقة بهذا الإجراء:

- فشل وصول الدم للفقرة ما يؤدي لضررها، وما قد يتطلب

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

cause damage. This may need further surgery.

- Excess fluid loss from the stoma.
- Stoma prolapse - the bowel protrudes past skin.
- Parastomal hernia - the bowel pushes through a weak point in the muscle wall, causing pain.
- Local skin irritation - reddening of the skin and a rash in reaction to the stoma bag glue.
- Bleeding into the abdomen. A blood transfusion and further surgery may be necessary.
- Damage to the tube bringing the urine from the kidney to the bladder.
- Abnormal emptying of the bladder. It may empty without control or may not empty at all.
- Inability to have and/ or maintain an erection in men. In women, it can cause pain during or after intercourse.
- The wound may be abnormal and the wound can be thickened, red and painful.
- The bowel actions may be much looser after the operation than before.
- Adhesions (bands of scar tissue) develop in the abdominal cavity and the bowel may block.
- Death within 30 days of surgery is estimated at 1 in 16 to 1 in 63.

D. Significant Risks and Procedure Options

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

تدخل جراحي إضافي.

- فقدان زائد للسوائل من الفقرة.
- نتوء زائد للأمعاء خارج سطح الجسم.
- فتق الفقرة حيث من الممكن أن تضغط الأمعاء على نقطة ضعف في الدار العضلي مسببة للألم.
- تهيج محلي للجلد - ظهور احمرار وطفح جلدي كرد فعل لغراء كيس الفقرة.
- نزيف إلى داخل تجويف البطن. قد يتطلب ذلك عملية نقل دم وتدخل جراحي.
- تضرر الأنبوب الموصل للبول من الكلى للمثانة.
- اضطراب في عملية إفراغ المثانة. قد تفرغ المثانة بدون تحكّم أو قد لا تفرغ على الإطلاق.
- عدم قدرة الرجال على الانتصاب أو الحفاظ على الانتصاب. أمّا للنساء فقد يشكين من ألم خلال أو بعد الجماع.
- قد يكون الجرح غير طبيعي أو قد يكون سميكاً أو محمراً ومؤلماً.
- حركة الأمعاء قد تكون أكثر مرونة بعد العملية من ذي قبل.
- إمكانية تشكل التصاقات (جّراء الندبات) مسببة انسداداً للأمعاء.
- نسبة الوفاة في غضون شهر بعد العملية تتراوح ما بين 1 من 16 حالة إلى 1 من 63 حالة.

د. المخاطر المعتمدة وخيارات الإجراء الطبي

(يقوم الطبيب بالتوثيق في المساحة المخصصة أدناه، ويكمل في السجل الطبي إن لزم الأمر)

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

E. Risks of not having this procedure

(Doctor to document in space provided. Continue in Medical Record if necessary.)

F. Anesthetic

This procedure may require an anaesthetic. (Doctor to document type of anaesthetic discussed)

G. Patient Consent

I acknowledge that the doctor has explained;

- My medical condition and the proposed procedure, including additional treatment if the doctor finds something unexpected. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- The anaesthetic required for this procedure. I understand the risks, including the risks that are specific to me.
- Other relevant procedure/treatment options and their associated risks.
- My prognosis and the risks of not having the procedure.
- That no guarantee has been made that the

ه . مخاطر عدم إجراء العملية

(يقوم الطبيب بالتوثيق في المساحة المخصصة أدناه، ويكمل في السجل الطبي إن لزم الأمر)

و . التخدير

قد تتطلب هذه العملية استخدام مخدر (يقوم الطبيب بتوثيق نوع المخدر الذي تم مناقشته)

ز . موافقة المريض

أقر بأن الطبيب قام يشرح ما يلي:

- حالتي المرضية والعملية المقترحة مع احتمالية لزوم القيام بإجراء طبي أو عملية إضافية في حالة إن وجد الطبيب أمراً غير متوقع. أدرك تماماً مخاطر العملية بالإضافة إلى المخاطر التي تتعلق بحالتي وظروفي الشخصية.
- التخدير اللازم للعملية، مع إدراكي التام لمخاطر التخدير بالإضافة إلى المخاطر التي تتعلق بحالتي وظروفي الشخصية.
- إجراءات أو خيارات علاج أخرى، والمخاطر المرافقة لها.
- تشخيصي حالتي الطبية ومخاطر عدم إجراء العملية.
- عدم وجود ضمانات بتحسين حالتي بعد العملية على الرغم من

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

procedure will improve my condition even though it has been carried out with due professional care.

- The procedure may include a blood transfusion.
- Tissues and blood may be removed and could be used for diagnosis or management of my condition, stored and disposed of sensitively by the hospital.
- If immediate life-threatening events happen during the procedure, they will be treated based on my discussions with the doctor or my Acute Resuscitation Plan.
- A doctor other than the Consultant may conduct the procedure. I understand this could be a doctor undergoing further training.

I have been given the following Patient Information Sheet/s:

- ☐ About Your Anaesthetic
- ☐ Epidural & Spinal Anaesthetic
- ☐ Abdominoperineal Resection of Rectum
- ☐ Blood & Blood Products Transfusion

- I was able to ask questions and raise concerns with the doctor about my condition, the proposed procedure and its risks, and my treatment options. My questions and concerns have been discussed and answered to my satisfaction.
- I understand I have the right to change my mind at any time, including after I have signed this form but, preferably following a discussion with my doctor.
- I understand that image/s or video footage may

أنها نفذت مع العناية المهنية الواجبة.

- قد تتضمن العملية إجراء عملية نقل الدم.
- قد يتم إزالة بعض الدم والأنسجة واستخدامها للتشخيص أو إدارة حالتي، وسيقام تخزينها والتخلص منها بحساسية من قبل المستشفى.
- سيتم معالجة أي حدث طارئ مهدد للحياة طبقاً لما تم مناقشته مع الطبيب أو طبقاً لخطة الإنعاش.
- قد يجري العملية طبيب غير الطبيب الاستشاري، وقد يكون الطبيب مازال قيد التدريب

أقر بأنني قد تلقيت نشرة المعلومات الصحية للمريض التالية

- ☐ التخدير المستخدم
- ☐ التخدير النخاعي والتخدير حول الجافية
- ☐ الاستئصال البطني العجاني
- ☐ نقل الدم ومنتجات الدم

- كنت قادراً على مناقشة وطرح كل تساؤلاتي ومخاوفي على الطبيب بخصوص حالتي ومخاطر الإجراءات والخيارات المتاحة لعلاجي، وأنا راض عن الأجوبة التي تلقيتها.
- أنا على إدراك تام بحقي في تغيير رأيي في أي وقت، حتى بعد توقيع هذه الاستمارة، ويفضل أن يكون بعد مناقشة الطبيب.
- أنا أفهم بأنه قد يتم أخذ صور أو تسجيل فيديو خلال العملية

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

be recorded as part of and during my procedure and that these image/s or video/s will assist the doctor to provide appropriate treatment.

On the basis of the above statements,

I request to have the procedure

Name of Patient:

Signature:

Date: Time:

Patients who lack capacity to provide consent

Consent must be obtained from a substitute decision maker/s in the order below.

Name of Substitute

Decision Maker/s:

Signature:

Relationship to patient:

Date: Time:

Contact No:

H. Doctor/delegate statement

I have explained to the patient all the above points under the Patient Consent section (G) and I am of the opinion that the patient/substitute decision-maker has understood the information.

Name of
Doctor/delegate:

Designation:

Signature:

Date: Time:

لمساعدة الطبيب على تقديم العلاج والإجراء المناسبين.
وعلى أساس البيانات المذكورة أعلاه.

أقر بموافقتي على تلقي العملية \ الإجراء الطبي

اسم المريض:

التوقيع:

التاريخ: الوقت:

المرضى الذين يفتقرون إلى القدرة على تقديم الموافقة
يجب الحصول على الموافقة من الوكيل أو الوصي بالترتيب أدناه.

اسم الوكيل/الوكلاء:

التوقيع:

صلة القرابة مع المريض:

التاريخ: الوقت:

رقم الاتصال:

ح. بيان الطبيب/المندوب

أقرّ بأنّي قمت بشرح جميع النقاط تحت قسم موافقة المريض (ز)

للمريض، ورأيي أن المريض/المندوب عنه قد فهم جميع المعلومات.

اسم الطبيب/المندوب:

المنصب:

التوقيع:

التاريخ: الوقت:

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

Witnesses (for the above signature)

1) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

2) Name: _____ Signature: _____

Date: _____ Time: _____

توقيع الشهود :

(1) الاسم: _____ التاريخ: _____

التوقيع: _____ الوقت : _____

(2) الاسم: _____ التاريخ: _____

الوقت : _____ التوقيع: _____